Клинические рекомендации

Острый синусит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J01** — Острый синусит
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.10.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/313_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Главное 2

2. Клиника и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Критерии диагноза 2

2.3 Тяжесть 3

2.4 Классификация 3

2.5 Дифференциальная диагностика 3

3. Диагностика 3

4. Лечение 4

4.1 Когда нужен антибиотик 4

4.2 Дозы стартовой терапии 4

4.3 Тяжёлое течение, парентерально 6

4.4 Местная и симптоматическая терапия 6

4.5 Хирургия 7

4.6 Профилактика 7

4.7 Особые случаи 7

5. Госпитализация и осложнения 7

6. Источник и актуальность 7

6.1 Что исправлено после сверки с PDF 8

6.2 Неточности в самом тексте КР 8

6.3 Шкалы доказательности 8

1. Главное

- Острый синусит — острое воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, которое длится меньше 12 недель. Должны быть хотя бы два симптома: заложенность носа, выделения из носа или носоглотки, давление или боль в области лица, снижение или потеря обоняния.
- В 90–98% случаев синусит вызывают вирусы, бактерии — лишь в 2–10%.
- Системные антибиотики назначают при среднетяжёлом и тяжёлом синусите. При лёгком — только если синусит рецидивирующий и симптомы держатся 5–7 дней и дольше, при тяжёлой сопутствующей патологии или иммунодефиците.
- При впервые возникшем синусите начинают с незащищённого аминопенициллина — амоксициллина. Если за 3 дня заметного эффекта нет, препарат меняют.
- Сосудосуживающие капли назначают не дольше 5–7 дней, нос промывают солевыми растворами, пациентам старше 12 лет можно интраназальные глюкокортикостероиды.
- Госпитализируют при тяжёлом течении, орбитальных или внутричерепных осложнениях, если за 3–5 дней приёма системных антибиотиков нет улучшения и при ухудшении в любой момент.

2. Клиника и классификация

раздел 1 текста КР

2.1 Определение

Острый синусит — острое воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, которое длится меньше 12 недель. Должны быть хотя бы два симптома: затруднённое носовое дыхание, выделения из носа или носоглотки, давление или боль в области лица, снижение или потеря обоняния. Часть симптомов может заменить находка при риноскопии, эндоскопии или на КТ.

У детей внезапно появляются хотя бы два симптома: заложенность носа, бесцветные или светлые выделения, кашель днём или ночью. Симптомы должны полностью пройти за 12 недель.

Рецидивирующим синусит называют, если за последний год было 4 эпизода и больше, а между ними — не меньше 8 недель без симптомов и без лечения.

Об остром поствирусном синусите говорят, если симптомы держатся дольше 10 дней после ОРВИ, а признаков бактериального синусита нет. Обычно он протекает легче и проходит без антибиотиков.

2.2 Критерии диагноза

У взрослых синусит начинается остро, симптомов два или больше, и один из них — заложенность носа или выделения, в том числе стекание слизи по задней стенке глотки. Могут быть боль или давление в проекции пазух, снижение или потеря обоняния. Длится не дольше 12 недель.

У детей синусит начинается остро, есть хотя бы два симптома: заложенность носа, выделения из носа, в том числе по задней стенке глотки, или кашель. Длится не дольше 12 недель.

Предварительный диагноз оториноларинголог подтверждает риноскопией или эндоскопией (гнойное отделяемое или отёк в области остиомеатального комплекса) либо КТ.

Боли может и не быть. При верхнечелюстном синусите она ощущается в проекции пазухи, реже в области переносицы и надбровья и может отдавать в верхние зубы. При сфеноидите болит в центре головы и в затылке, как будто надета каска.

У детей синусит часто сочетается с гипертрофией и хроническим воспалением глоточной миндалины и может проявляться упорным кашлем или сильно затруднённым носовым дыханием.

2.3 Тяжесть

Форма	Признаки
Лёгкая	Нет лихорадки. Умеренные симптомы, не влияющие или незначительно влияющие на качество жизни. Нет головной боли в проекции ОНП. Нет осложнений
Среднетяжёлая	Выраженные симптомы, умеренно или значительно влияющие на качество жизни. Тяжесть в проекции ОНП при движении или наклоне головы. Осложнение со стороны среднего уха (острый средний отит). Нет внутричерепных и орбитальных осложнений
Тяжёлая	Выраженные или мучительные симптомы. Болезненность в проекции ОНП, усиливающаяся при движении, наклоне головы, перкуссии. Внутричерепные или орбитальные осложнения

2.4 Классификация

По причине синусит бывает вирусным, бактериальным, травматическим, грибковым (как острый процесс — очень редко) и смешанным. Чисто бактериальный синусит встречается редко; обычно это сочетание вирусов или вирусов с бактериями.

По локализации различают гайморит, фронтит, этмоидит и сфеноидит. Если поражены все пазухи одной половины носа, это гемисинусит, если обеих — пансинусит.

2.5 Дифференциальная диагностика

У взрослых синусит отличают от обострения хронического риносинусита, аллергического и хронических ринитов, у детей — ещё от аденоидита и инородного тела в носу.

Дошкольникам без осложнений и без признаков бактериального синусита основным диагнозом лучше ставить аденоидит или острый назофарингит.

---

3. Диагностика

раздел 2 текста КР
Всем пациентам проводят общий осмотр и стандартный ЛОР-осмотр.

Эндоскопию полости носа и носоглотки проводят, чтобы оценить их состояние и провести дифференциальную диагностику.

Чаще всего она не даёт больше, чем передняя и средняя риноскопия, но помогает, например, отличить сфеноидит от аденоидита.

Спиральную КТ околоносовых пазух делают при подозрении на внутричерепные или орбитальные осложнения, при затяжном тяжёлом течении и в сложных диагностических случаях.

Рентгенографию пазух делают при среднетяжёлом и тяжёлом течении, а также в сложных случаях, если КТ сделать нельзя.

Рентгенография и КТ пазух совпадают только в 34% случаев, для верхнечелюстной пазухи — в 77%.

УЗИ пазух делают при подозрении на верхнечелюстной или лобный синусит, если рентгенография и КТ невозможны.

Развёрнутый общий анализ крови назначают при среднетяжёлом и тяжёлом течении.

Лейкоцитоз с нейтрофилёзом не доказывает бактериальный синусит, но если при повторном анализе он нарастает, это помогает решить вопрос об антибиотиках.

Гнойное отделяемое отправляют на посев с определением чувствительности в стационаре при среднетяжёлом и тяжёлом течении, при затяжном течении и если эмпирическая антибиотикотерапия не помогла.

Материал берут при пункции пазухи иглой Куликовского. Посев из носового хода делать бессмысленно: в него попадает посторонняя флора.

Другие исследования не нужны.

4. Лечение

раздел 3 текста КР

4.1 Когда нужен антибиотик

Взрослым антибиотики назначают при среднетяжёлом и тяжёлом синусите. При лёгком — только если синусит рецидивирующий и симптомы держатся 5–7 дней и дольше, а также при тяжёлой сопутствующей патологии (например, сахарном диабете) и иммунодефиците.

О бактериальном синусите говорят три признака и больше: гнойные выделения или выделения только из одной половины носа 3 дня и дольше; головная боль или давление в проекции верхнечелюстных или лобных пазух; температура 38,0 °C и выше; «вторая волна» болезни; лейкоцитоз выше 15×10^9/л. О нём же говорят выраженные с самого начала симптомы, которые держатся 3–4 дня и угрожают орбитальными или внутричерепными осложнениями.

Детям антибиотики назначают при признаках бактериального синусита, среднетяжёлом и тяжёлом течении. При лёгком — если есть хотя бы одно из условий: орбитальные или внутричерепные осложнения; три и больше признака бактериального синусита; иммунодефицит, муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, некомпенсированный сахарный диабет I типа; 4 эпизода синусита и больше за последний год.

Взрослым при наличии показаний назначают системные антибиотики.

Детям при наличии показаний назначают системные антибиотики.

При впервые возникшем синусите начинают с незащищённых аминопенициллинов.

Если высок риск устойчивого пневмококка, дозу амоксициллина повышают. При сопутствующих болезнях, иммуносупрессии, в возрасте старше 65 лет и если амоксициллин уже не помог, начинают с защищённых аминопенициллинов.

Если за 3 дня заметного эффекта нет, препарат меняют, не дожидаясь конца курса. У детей эффект оценивают через 48–72 часа.

4.2 Дозы стартовой терапии

Взрослые

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	500 мг × 3 р/сут — без факторов риска[1] 1000 мг × 3 р/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь[2]	500/125 мг × 3 р/сут или 875/125 мг × 2 р/сут
Цефуроксим	250–500 мг × 2 р/сут
Цефиксим	400 мг × 1 р/сут
Цефдиторен внутрь	200 мг × 2 р/сут

Препарат	Доза
Цефподоксим внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	250–500 мг × 2 р/сут
Левофлоксацин внутрь	500 мг × 1 р/сут
Моксифлоксацин внутрь	400 мг × 1 р/сут
Клиндамицин в/м (в КР — со знаком #)	400–900 мг × 3 р/сут, 7–10 дней

[1] Риск устойчивости пневмококка повышают антибиотики в предыдущие 3 месяца, дети-дошкольники в семье, которые ходят в детский сад, и проживание в закрытых учреждениях.

[2] Риск бета-лактамаз (H. influenzae, S. aureus, M. catarrhalis) повышают бронхиальная астма, сахарный диабет, хронический бронхит, иммуносупрессия, возраст старше 65 лет и неудачное лечение амоксициллином.

Неосложнённый синусит лечат 7 дней, осложнённый — 10–14 дней.

Макролиды — только запасной вариант при IgE-опосредованной непереносимости бета-лактамов. Фторхинолоны можно только взрослым и только если других вариантов нет; детям и подросткам они противопоказаны.

Дети

Препарат	Доза
Амоксициллин внутрь	40–60 мг/кг/сут — без факторов риска[1] 80–90 мг/кг/сут — при факторах риска[1]
Амоксициллин + клавулановая кислота внутрь	45–60 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Цефуроксим	30 мг/кг/сут в 2 приёма, не более 500 мг в сутки
Цефиксим	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен, цефподоксим (старше 12 лет) внутрь	200 мг × 2 р/сут
Аллергия на β-лактамы	
Кларитромицин внутрь	15 мг/кг/сут в 2 приёма, макс. 1000 мг/сут
Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат в/м (стационар, если β-лактамы невозможны)	125–250 мг 2–3 р/сут в зависимости от возраста

Амоксициллин с клавулановой кислотой назначают, если за последние 3 месяца ребёнок получал антибиотики или ходит в детский коллектив, а также если амоксициллин не помог за 48–72 часа. При лёгкой аллергии на пенициллины назначают цефалоспорины III поколения внутрь.

Дозы на килограмм рассчитаны на детей с массой меньше 40 кг; при массе 40 кг и больше назначают взрослые дозы.

Неосложнённый синусит лечат 7–10 дней, при орбитальных и внутричерепных осложнениях или рецидивирующем течении — 10–14 дней.

> Внутри КР есть расхождение: в тексте раздела 3.1 стартовая доза амоксициллина для детей — 50–60 мг/кг в сутки в 2–3 приёма, а в таблице 5 — 40–60 мг/кг в сутки (80–90 мг/кг при факторах риска). На сайте приведены данные таблицы.

4.3 Тяжёлое течение, парентерально

Взрослым при тяжёлом синусите вводят цефотаксим или цефтриаксон, внутривенно можно также амоксициллин с клавулановой кислотой. При риске анаэробов назначают клиндамицин вместе с цефалоспорином III поколения. Если стартовая парентеральная терапия не помогла, рассматривают цефоперазон с сульбактамом 2–4 г в сутки внутривенно в 2 введения, а при резистентных штаммах — препараты резерва по чувствительности.

Детям вводят ампициллин с сульбактамом 300 мг/кг в сутки в 3–4 введения, цефтриаксон 75 мг/кг в сутки в 2 введения или цефотаксим 100–200 мг/кг в сутки в 4 введения. Если это не помогло, назначают цефоперазон с сульбактамом 75–160 мг/кг в сутки в 2–4 введения (в КР — со знаком #, то есть вне инструкции).

4.4 Местная и симптоматическая терапия

Нос промывают изотонической стерильной морской водой или солевыми растворами. Слабые гипертонические растворы используют только в остром периоде и не дольше 5–7 дней.

Сосудосуживающие капли КР называет абсолютно необходимыми, но ограничивает их 5–7 днями из-за риска медикаментозного ринита. Нафазолин не применяют.

Детям до 6 лет подходят фенилэфрин 0,125%, оксиметазолин 0,01–0,025% и ксилометазолин 0,05% (с 2 лет).

Интраназальные глюкокортикостероиды пациентам старше 12 лет назначают одни при затяжном поствирусном синусите или вместе с системными антибиотиками. Детям до 12 лет одни глюкокортикостероиды назначают только при сопутствующем аллергическом рините.

Для лечения синусита без признаков бактериальной инфекции одним препаратом в России зарегистрирован только спрей мометазона.

Местные антибактериальные препараты назначают вместе с системными или одни при лёгком синусите с признаками бактериального воспаления (гнойными выделениями). Эффект оценивают через 3–4 дня.

При синусите зарегистрированы фрамицетин (детям с первых лет жизни) и комбинация дексаметазона, неомицина, полимиксина B и фенилэфрина (с 2,5 лет). Растворы антибиотиков для инъекций вводить в нос и пазухи нельзя.

При температуре, головной и лицевой боли назначают НПВП. Детям до 6 лет — только парацетамол (до 60 мг/кг в сутки) или ибупрофен (до 30 мг/кг в сутки), взрослым можно кетопрофен.

Можно назначить мукоактивные препараты, например ацетилцистеин или карбоцистеин. Перед назначением проверьте инструкцию: не все они разрешены при ЛОР-болезнях и вместе с антибиотиками.

Применяют растительные препараты с доказанным противовоспалительным и муколитическим действием: комбинации корня горечавки, цветков первоцвета, шалфея, цветков бузины и вербены, миртол, экстракт пеларгонии сидовидной.

Комбинированные препараты с парацетамолом без психотропных компонентов можно давать для облегчения симптомов с 12 лет.

Системные антигистаминные препараты назначают при сопутствующем аллергическом рините и в начале вирусной инфекции.

При вирусном синусите в комплексное лечение можно включить противовирусные препараты, в том числе растительного происхождения.

При лёгком синусите амбулаторно можно рассмотреть комплексные гомеопатические препараты по зарегистрированным показаниям.

Бактериофаги назначают взрослым с острым бактериальным синуситом; местно они оправданы при устойчивости к антибиотикам или их непереносимости.

4.5 Хирургия

Пункцию верхнечелюстной пазухи делают, если содержимое в пазухе подтверждено рентгенологически и течение тяжёлое или среднетяжёлое без эффекта от лечения с системными антибиотиками за 5–7 дней.

Детям пункцию и трепанопункцию делают только в стационаре; часто вместо них можно использовать синус-катетер.

Дренирование пазух, в том числе синус-катетером, проводят при затяжном экссудативном синусите без обструкции соустий. При впервые возникшем неосложнённом синусите оно не нужно.

При орбитальных или внутричерепных осложнениях оперируют в стационаре: вскрывают пазуху и дренируют абсцесс.

Другое лечение (раздел 3.3) и медицинская реабилитация (раздел 4) не нужны.

4.6 Профилактика

Детям из групп риска по респираторным болезням назначают местные и системные лизаты бактерий.

При рецидивирующем синусите и изменениях перегородки или латеральной стенки носа, которые к нему предрасполагают, проводят плановую операцию.

4.7 Особые случаи

Сопутствующий аллергический ринит затягивает синусит: нужны системные антигистаминные препараты и более высокая доза глюкокортикостероидов.

Одонтогенный синусит лечат хирургически, удаляя пломбировочный материал и секвестры. Из антибиотиков предпочтительны респираторные фторхинолоны, потому что преобладает анаэробная флора.

5. Госпитализация и осложнения

разделы 1.5, 3 и 6 текста КР
Экстренно в ЛОР-отделение госпитализируют при тяжёлом течении, в том числе с орбитальными и внутричерепными осложнениями, если за 3–5 дней системных антибиотиков нет улучшения и при прогрессирующем ухудшении в любой момент.

Орбитальные и внутричерепные осложнения говорят о тяжёлом течении, острый средний отит — о среднетяжёлом.

Выписывают, когда состояние стабильно удовлетворительное не меньше 3 дней.

6. Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый синусит»
Версия	3-я, год утверждения 2024, опубликована в рубрикаторе 28.10.2024

Статус	**Применяется** (карточка рубрикатора на 22.10.2026); год окончания действия не указан
Актуализация	По правилу из самой КР — «не реже чем один раз в три года» (прил. А2): следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	313_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети
Целевая аудитория	Оториноларингологи, терапевты, педиатры

6.1 Что исправлено после сверки с PDF

- Убрано предупреждение «пересмотр не позднее 2026»: в PDF и в карточке рубрикатора этой даты нет, она пришла из пересказа MedElement.
- Амоксициллин у взрослых: «500–1000 мг» заменено на две дозы с условием — 500 мг без факторов риска устойчивости пневмококка, 1000 мг при их наличии.
- Добавлены условия для амоксициллина/клавуланата и цефоперазона/сульбактама, тиамфеникол для детей в стационаре, предел цефуроксима «500 мг в сутки».
- Уточнены показания к пункции, ограничение ИГКС до 12 лет (только монотерапия), признаки степеней тяжести, критерии у детей («бесцветные или светлые выделения»).
- Убрана фраза «КТ рутинно не нужна»: в КР её нет.
- Добавлены разделы 5 «Профилактика» и 7 «Дополнительная информация».

6.2 Неточности в самом тексте КР

- Детская доза амоксициллина: текст раздела 3.1 — 50–60 мг/кг/сут, таблица 5 — 40–60 (80–90) мг/кг/сут.
- В таблице 5 у цефтриаксона указан код АТХ J01FA09 — это код кларитромицина; в тексте у цефтриаксона верный код J01DD04.
- Знак # у ряда препаратов в этой КР не расшифрован. ⚠ В российских КР им обычно отмечают применение вне инструкции — проверьте по инструкции препарата.

6.3 Шкалы доказательности

Шкала	Что означает
УУР А	Сильная рекомендация: все критерии эффективности важны, исследования высокого или удовлетворительного качества, выводы согласованы
УУР В	Условная рекомендация: не все критерии важны, не все исследования высокого качества и/или выводы не согласованы
УУР С	Слабая рекомендация: доказательств надлежащего качества нет
УДД 1–5	Для лечения: 1 — систематический обзор РКИ с метаанализом … 5 — только обоснование механизма действия или мнение экспертов. Для диагностики — отдельная шкала (табл. П1); точная расшифровка — по нажатию на бейдж